VISIONSEEK

VisionSeek · ARABIC HEALTH AI · v1.1

هل نثق بالذكاء الاصطناعي في صحتنا؟

مبني على بحث أجرته VisionSeek

أكتوبر 2026

إعداد: د. أحمد عبدالعليم، VisionSeek — إنتشون، كوريا الجنوبية

المراجعة أُجريت بالذكاء الاصطناعي، ولم يراجعها صيدلي بشري

DOI 10.5281/zenodo.23657799

مفتاح الوسوم: [مؤكد بمصدر] = من بحث VisionSeek وبياناته المنشورة (التفاصيل في §6). [استنتاج] = قراءة VisionSeek لصانع القرار.

إفصاح المراجعة: المراجعة السريرية أُجريت بالذكاء الاصطناعي، ولم يراجع المحتوى ولا الإجابات صيدلي بشري ولا طبيب [مؤكد بمصدر].

سياسة النص الرسمي: هذا التقرير لا ينقل نص وزارات الصحة ولا يعيد صياغته؛ يعرض الأسئلة وروابط المصادر الرسمية فقط.

1. الملخص التنفيذي

المراجعة أُجريت بالذكاء الاصطناعي، ولم يراجعها صيدلي بشري. نموذجان ذكيان من عائلتين مختلفتين قاما بدور الصيدلي السريري في الحكم على الأسئلة والإجابات [مؤكد بمصدر].

خلاصات قابلة للاقتباس

1. **«المرجع هو ما تقوله الوزارة للمريض.»** بنت VisionSeek مجموعة من 69 سؤالًا صحيًا بالفصحى، لكل سؤال مرجع واحد: صفحة أو وثيقة توعوية رسمية لوزارة صحة خليجية برابطها؛ 48 سؤالًا من تسع صفحات لوزارة الصحة السعودية و21 من وثيقتين لوزارة الصحة العُمانية [مؤكد بمصدر].
2. **«الخطأ الأوضح كان في موعد بسيط.»** حين سُئل النموذج متى يراجع مريض السكري طبيبه قبل رمضان، أجاب بالسنوات؛ خطأ صريح في تعليمة يعرفها المصدر الرسمي بوضوح [مؤكد بمصدر]. التعليمات المرتبطة بالوقت تحتاج اختبارًا مستقلًا قبل أن يعتمد عليها الجمهور [استنتاج].
3. **«13 من 17.»** في الأسئلة التي جوابها الرسمي رقم، ذكر النموذج كل الأرقام الصحيحة في 13 من 17 حالة، وفي الأربع الباقية اختلافان جوهريان عن النص الرسمي. وإحدى الحالات الناجحة نجحت جزئيًا بالصدفة، وأضافت أهدافًا علاجية ليست في المصدر [مؤكد بمصدر].
4. **«المعقول طبيًا ليس دائمًا الرسمي.»** أضاف النموذج أحيانًا نصائح غير موجودة في نص الوزارة، أو استبدل بها أرقامًا من إرشادات أخرى. القياس على الإرشاد الوطني يكشف ذلك فورًا [مؤكد بمصدر].
5. **«الخليج غير متساوٍ في المحتوى الصحي العام.»** في حدود ما جُرد، تنشر السعودية وعُمان محتوى توعويًا موجّهًا للمريض، بينما يغلب على مواقع الوزارات الأخرى أخبار الحملات وصفحات الخدمات والاستراتيجيات [مؤكد بمصدر]. قد تكون هذه فجوة محتوى عام [استنتاج]؛ وحدود الجرد في §6.
6. **«الترخيص يحدّد ما يُنشر.»** لقيود ترخيص في شروط البوابة السعودية يقتصر ما تنشره VisionSeek من المجموعة على الأسئلة والروابط وأدوات التقييم، ويلتزم هذا التقرير بالشروط المنشورة للبوابة [مؤكد بمصدر].

2. ماذا وجدنا

2.1 ما الذي بُني

- أسئلة في 4 موضوعات تهم المريض الخليجي: السكري، والسمنة، واستخدام الأدوية، والصيام في رمضان، بعد جرد مواقع وزارات الصحة في دول المجلس الست [مؤكد بمصدر].
- 69 سؤالًا بالفصحى مرتبطة بـ11 مصدرًا رسميًا: 9 صفحات سعودية ووثيقتان عُمانيتان [مؤكد بمصدر].
- 17 سؤالًا تخص الأدوية وسلامتها: 13 سعودية و4 عُمانية [مؤكد بمصدر].
- الأسئلة السعودية: الصيام 24، والسكري 10، والأدوية 9، والسمنة 5؛ والعُمانية: الصيام 18، والأدوية 3 [مؤكد بمصدر].

2.2 السؤال بلهجة السائل

لكل سؤال نسخة سعودية وأخرى كويتية، 138 نسخة في المجموع، صاغتها نماذج ذكية مجانية. حافظت النسخ كلها على الأرقام وأسماء الأدوية، وقُبلت 136 منها من المراجعة الآلية الأولى، والاثنتان الباقيتان بعد تعديل واحد [مؤكد بمصدر]. لم يعتمدها بعدُ متحدثون أصليون للهجتين [مؤكد بمصدر].

2.3 كيف أجاب نموذج ذكي

اختُبر نموذج واحد متاح مجانًا (Gemini Flash-Lite) على الأسئلة السعودية الـ48، فأجاب عنها كلها [مؤكد بمصدر]. في الأسئلة الأربعة التي تعثّر فيها الفحص الرقمي:

- سؤال موعد المراجعة قبل رمضان: خطأ صريح في وحدة الزمن.
- سؤال عدد مرات قياس السكر لمرضى الخطورة العالية: إجابة متسقة جزئيًا.
- سؤال هدف السكر بعد الأكل: إجابة صحيحة كتبت الأرقام بالحروف ففاتت الفحص الآلي.
- سؤال إنقاص الوزن في مرحلة ما قبل السكري: إجابة غير متسقة مع النص الرسمي [مؤكد بمصدر].

2.4 ماذا قال «الصيدلي الآلي»

- **لم يُصنَّف أي سؤال ولا أي إجابة بأنها غير آمنة أو عالية الضرر** [مؤكد بمصدر].
- ثلاث إجابات ناقضت المرجع الرسمي وقُدّر ضررها المحتمل بأنه منخفض: موعد المراجعة قبل رمضان، وعدد مرات القياس لمرضى الخطورة المنخفضة، وكمية الدواء في السفر [مؤكد بمصدر].
- خمسة أسئلة رأى فيها مراجِع آلي واحد على الأقل أن النص الرسمي نفسه يستدعي الحذر، واثنان منها قد يكونان أقدم من الإرشاد الدولي الحالي لصيام مرضى السكري [مؤكد بمصدر]. هذه إشارة للوزارة لمراجعة نصها، لا حكم عليه [استنتاج].
- اتفق المراجِعان الآليان كثيرًا في الأرقام الخام، لكن اتفاقهما الحقيقي بعد استبعاد الصدفة متواضع، وأضعفه في الحكم على اكتمال الإجابة [مؤكد بمصدر]. لذلك هذه المراجعة أداة فرز لا حكم سريري [استنتاج].

2.5 أسئلة مختارة مع روابطها الرسمية

السؤال	المصدر الرسمي
متى يجب على مريض السكري مراجعة مقدم الرعاية الصحية قبل صيام رمضان؟	وزارة الصحة السعودية
كم مرة يفحص مريض السكري منخفض المخاطر سكره في رمضان؟	وزارة الصحة السعودية
كم يُنصح بإنقاص الوزن في مرحلة ما قبل السكري؟	وزارة الصحة السعودية
كم كمية الدواء التي يأخذها مريض السكري معه عند السفر؟	وزارة الصحة السعودية
هل يجوز تناول الأسبرين مع الوارفارين؟	وزارة الصحة السعودية
متى يتوجب على مريض السكري الإفطار بسبب ارتفاع السكر؟	وزارة الصحة العُمانية

الإجابة الرسمية تُقرأ من موقع الوزارة مباشرة؛ التقرير لا ينقلها.

3. ماذا يعني هذا لقادة الصحة في الخليج

1. **اجعلوا إرشادكم الوطني مرجع الاختبار.** أي مساعد ذكي يجيب جمهوركم يُقاس بما تقوله وزارتكم، لا بما يبدو «معقولًا طبيًا» [استنتاج].
2. **انشروا محتوى توعويًا منظّمًا للمريض.** ما لا يُنشر لا يمكن قياس النماذج عليه، وتبقى الدولة خارج الصورة [استنتاج].
3. **وضّحوا شروط إعادة الاستخدام.** شروط واضحة للاستخدام البحثي تسهّل بناء أدوات تقييم عامة [استنتاج].
4. **ابدأوا بالمواعيد والكميات.** التوقيت والكمية وعدد مرات القياس هي مواضع الأخطاء التي ظهرت [مؤكد بمصدر]؛ والتداخلات الدوائية تستحق أولوية في الاختبار [استنتاج].
5. **أدخلوا الصيدلي البشري.** المراجعة الآلية تفرز، والقرار السريري يبقى لصيادلة وأطباء [استنتاج].
6. **اختبروا بلهجة الناس.** المريض يسأل بلهجته؛ والنسخ السعودية والكويتية جاهزة للاختبار [استنتاج].

4. نطاق الإصدار ومصادره

- **المراجعة أُجريت بالذكاء الاصطناعي، ولم يراجعها صيدلي بشري.** أحد المراجِعَين الآليين من عائلة النموذج المُختبَر نفسها [مؤكد بمصدر].
- الاختبار شمل نموذجًا واحدًا على 48 سؤالًا سعوديًا؛ هو فحص لصلاحية الطريقة، ولا يقارن بين النماذج [مؤكد بمصدر].
- النسخ اللهجية من صياغة نماذج ذكية ومراجعتها [مؤكد بمصدر].
- الاتساق مع نص الوزارة ليس مرادفًا للصحة السريرية؛ فالنص الرسمي قد يكون مبسّطًا أو قديمًا [مؤكد بمصدر].
- كل الأرقام من بحث VisionSeek وبياناته المنشورة. لا ينقل التقرير نصًا من أي جهة صحية، ومخرجاته للتقييم فقط وليست نصيحة صحية [مؤكد بمصدر].

5. أسئلة مفتوحة للإصدار التالي

1. كيف تتغير الإجابات حين يُطرح السؤال نفسه باللهجة السعودية أو الكويتية؟
2. كيف يجيب النموذج عن الأسئلة العُمانية الـ21؟
3. كيف تُقارن نماذج طوّرها الخليج (ALLaM وFanar وJais) بالنماذج العالمية؟
4. ما شروط الاستخدام لدى الوزارات الخمس الأخرى، وأين المحتوى التوعوي الكويتي؟
5. ماذا يقول صيدلي بشري عن أسئلة الأدوية الـ17؟

6. كيف بُني التقرير

- **المصدر:** بحث أجرته VisionSeek (نسخة أولية 2026 ،v1.0؛ العنوان الكامل في §7) وملفات بياناته المنشورة.
- **DOI:** 10.5281/zenodo.23657799
- **المراجعة الآلية:** المراجعة أُجريت بالذكاء الاصطناعي، ولم يراجعها صيدلي بشري ولا طبيب. نموذجان (gemma-4-26b-a4b-it وgemini-3.5-flash-lite) بدور صيدلي سريري، كلٌّ مستقل عن الآخر (§3.7، §6).
- **الاتفاق بين المراجِعَين (الجولة العمياء، κ):** الأسئلة (69): الصحة 92.8% (κ=0.52)، السلامة 92.8% (κ=0.26). الإجابات (48): الدقة 81.2% (κ=0.31)، الاكتمال 81.2% (κ=0.07)، الضرر 95.8% (κ=0.64). بقي 5 أسئلة و5 إجابات معلّمة بخلاف؛ والبحث يصف الاتفاق بأنه متواضع (κ 0.07–0.64) (§6، §4.4).
- **المعرّفات:** موعد المراجعة P4-001؛ القياس لمرضى الخطورة العالية P4-010 والمنخفضة P4-009؛ هدف ما بعد الأكل P4-013؛ إنقاص الوزن P4-031؛ دواء السفر P4-035؛ الأسئلة الخمسة «بحذر» P4-004 وP4-023 وP4-038 وP4-062 وP4-069، والاثنان المحتمل قِدمهما مقارنة بإرشاد IDF-DAR هما P4-062 و(§4.4، §4.2) P4-069.
- **الفحص الرقمي:** يفوّت الأرقام المكتوبة بالحروف ولا يقيّم الأسئلة غير الرقمية؛ ونجاح «A1C» الجزئي أثر آلي (§4.2، §6).
- **حدود الجرد:** موقع وزارة الصحة الكويتية لم يستجب للطلبات الآلية وفحصه اليدوي لاحق، والجهات الصحية على مستوى الإمارة في الإمارات خارج النطاق، وشروط الاستخدام قُرئت للسعودية (§3.1، §3.2).
- **حدود أخرى:** الأسئلة كتبها الباحث دون بيانات أسئلة مستخدمين حقيقيين؛ بحث الأعمال السابقة استخدم OpenAlex بدل Semantic Scholar وGoogle Scholar؛ و4 أسئلة عُمانية نُسخت مرجعيتها من صورة الصفحة يدويًا لتعذّر OCR في الأرقام؛ والنسخ اللهجية لم يعتمدها متحدث أصلي (§3.4، §4.1، §6).
- **الترخيص:** شروط البوابة السعودية (§3.2).

7. للاستشهاد

Abdelalim, A. (2026). *Official-Source Health Information in MSA and Gulf Dialects: A Pilot Evaluation Set Grounded in GCC Ministry-of-Health Awareness Content, with AI Review in a Clinical-Pharmacist Role* (Preprint v1.0). VisionSeek, Incheon, South Korea. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23657799

وللتقرير: عبدالعليم، أحمد (2026). «هل نثق بالذكاء الاصطناعي في صحتنا؟». VisionSeek، إنتشون، كوريا الجنوبية، v1.1. https://visionseek.org/ar/reports/reports/ai-ministry-health-answers